Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 7ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810373

Processo nº 0002522-89.2025.8.17.2001

AUTOR(A): A. B. P. D. F.

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MENOR DE IDADE PORTADOR DE BAIXA ESTATURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA HORMÔNIO DE CRESCIMENTO. SOMATROPINA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. USO DOMICILIAR. REGISTRO NA ANVISA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA.

1. **Relação de consumo reconhecida.** Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre beneficiário e operadora de plano de saúde. Inteligência da Súmula 608 do STJ.
2. **Negativa de cobertura médica.** Medicamento prescrito por profissional especialista (Somatropina), com indicação formal para tratamento de deficiência de hormônio do crescimento em menor de idade.
3. **Registro sanitário e regularidade do fármaco.** Produto registrado junto à Anvisa, com indicação terapêutica reconhecida. Essencialidade comprovada. Alegação de exclusão contratual por uso domiciliar afastada diante da imprescindibilidade do tratamento.
4. **Doença preexistente.** Ausência de prova de diagnóstico fechado ou de ciência prévia da contratante no momento da adesão ao plano. Inexistência de perícia médica prévia ou comprovação de má-fé. Incidência da Súmula 609 do STJ e da RN nº 162/2007 da ANS.
5. **Cláusula limitativa.** Interpretação restritiva das exclusões de cobertura. Abusividade reconhecida à luz dos arts. 6º, I, e 51, IV, do CDC. Direito fundamental à saúde prevalente.
6. **Dano moral configurado.** Recusa indevida de tratamento médico essencial impõe angústia desproporcional à paciente e sua família. Dever de indenizar reconhecido.
7. **Pedidos que se julgam procedentes.**

Vistos etc...

Cuida-se de **ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência** ajuizada por **A. B. P. D. F.**, menor representada por sua genitora, contra **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, visando obter a **determinação judicial de fornecimento contínuo e imediato do medicamento Somatropina (Genotropin)**, conforme prescrição médica anexa.

Alega a parte autora que é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão mantido junto à ré, estando em regularidade quanto ao adimplemento das mensalidades. Narra que, diante do quadro clínico de baixa estatura grave associada a deficiência do hormônio do crescimento, conforme exames e laudo médico acostados, houve prescrição do medicamento Somatropina, de uso contínuo, com indicação expressa de que sua ausência pode comprometer o desenvolvimento físico e psicológico da infante.

Apesar disso, relata que teve **negado administrativamente o fornecimento do fármaco** sob o argumento de que o contrato não prevê cobertura para o referido item. Sustenta que tal negativa é abusiva, ferindo os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, sobretudo quando se trata de medicamento essencial à preservação da saúde e da vida de menor.

Requer, **em sede de tutela provisória de urgência**, o imediato fornecimento do medicamento conforme prescrição, com prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela **confirmação da liminar e condenação da ré à obrigação de fornecer o medicamento enquanto perdurar a necessidade médica**, com custeio integral, sob pena de astreintes. Formula ainda pedido subsidiário para que, não sendo possível o fornecimento, seja autorizada a aquisição direta com reembolso integral das despesas. Pede ainda **indenização por danos morais** que estima em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Junta aos autos diversos documentos comprobatórios da condição de saúde da menor, do vínculo contratual, da negativa administrativa, da prescrição médica e da hipossuficiência econômica, inclusive pleiteando a gratuidade de justiça.

Foi proferida **decisão** sob ID nº 192475925 **deferindo** a mercê do **art. 98, CPC**, e a **tutela da urgência** para "*para determinar que a empresa demandada, no prazo de dez (10) dias úteis, passe a arcar com os custos do tratamento medicamentoso requisitado na inicial, incluindo toda a aparelhagem necessária para sua ministração, durante todo o período e em estrita consonância com a solicitação do médico endocrinologista assistente*".

Regularmente citada, sob ID nº 195203088, a ré, **Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico**, apresentou **contestação**.

De início, a operadora impugna os fundamentos da **tutela de urgência** requerida na inicial, argumentando que **não estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC**, notadamente a urgência e a verossimilhança do direito alegado. Alega que o quadro clínico da menor não evidencia estatura anormal para sua idade (138 cm aos 11 anos) e que **não há comprovação técnica de que o medicamento seja indispensável à preservação de sua saúde**. Acrescenta que os documentos acostados não demonstram que a altura da autora esteja desvinculada do padrão familiar, nem que o tratamento proposto seja inadiável ou insubstituível.

No mérito, sustenta que o medicamento pleiteado é de **uso domiciliar**, sendo expressamente **excluído da cobertura contratual**, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, e das normas da ANS. Argumenta que a operadora não possui obrigação legal de fornecer fármacos utilizados fora do ambiente hospitalar, salvo nos casos expressamente previstos. Defende a **validade da cláusula excludente**, afirmando que se trata de limitação contratual legítima, respaldada pela regulação do setor. Cita precedentes para amparar o entendimento de que **o fornecimento de hormônio de crescimento não é de cobertura obrigatória fora do regime hospitalar**, quando ausente previsão contratual.

Além disso, a ré levanta questionamento quanto à **eventual existência de doença preexistente omitida no momento da contratação**. Informa que o plano foi contratado em fevereiro de 2024, e que documentos médicos anexados à inicial indicam **histórico anterior de avaliação e possível início de tratamento hormonal**, o que, segundo sustenta, não foi declarado no formulário de saúde apresentado à época. Alega, assim, hipótese de **má-fé contratual**, com a omissão dolosa de informação relevante, apta a justificar a aplicação da **cobertura parcial temporária (CPT)** por até 24 meses, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 162/2007 da ANS.

Por fim, destaca o risco de **periculum in mora reverso**, advertindo que o eventual deferimento da liminar pode impor à operadora **ônus irreparável**, sobretudo diante da alegada hipossuficiência da parte autora e da ausência de possibilidade de ressarcimento, caso a demanda seja julgada improcedente. Ao final, requer o indeferimento da tutela antecipada e a **total improcedência da ação**, com a manutenção da negativa de fornecimento do medicamento, além da produção de prova pericial e o respeito à regular intimação do patrono constituído.

Sob ID nº 198624029, a parte autora apresentou **réplica** na qual refuta todas as alegações da contestação, com destaque para a defesa da tutela de urgência concedida, a qual entende estar amplamente respaldada em laudo médico subscrito por endocrinologista pediátrica, o qual atesta expressamente o diagnóstico de deficiência de hormônio do crescimento (CID E23.0) e a necessidade urgente do medicamento Somatropina (Genotropin).

Aduz que a ré, ao contestar o pedido, **usurpa indevidamente o papel do médico assistente** ao tentar deslegitimar a prescrição técnica e a gravidade da condição clínica. Alega que a **exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar** é abusiva, sobretudo diante da essencialidade da medicação e da ausência de alternativa terapêutica eficaz. Impugna também a tese de **doença preexistente não declarada**, ressaltando que **não havia diagnóstico à época da adesão ao plano**, sendo a investigação clínica realizada apenas posteriormente.

Rebate ainda a alegação de **periculum in mora reverso**, defendendo que a preservação do desenvolvimento físico da menor deve prevalecer sobre eventuais riscos econômicos à operadora. Por fim, **reitera a configuração do dano moral**, defendendo sua caracterização *in re ipsa*, e **impugna os documentos anexados pela ré**, por ausência de pertinência com os fundamentos da negativa de cobertura.

Seguiu-se **despacho** de ID nº 198981646 indagando os contendores sobre **interesse na autocomposição ou na dilação probatória**. Ainda, fora **invertido o ônus da prova** em desfavor da OPS demanda.

Em resposta, a parte **ré** reiterou pedido de **prova pericial** (ID nº 199948385) enquanto o **demandante** clamou pelo **julgamento antecipado da lide** (ID nº 200146062)..

Adveio **decisão** de ID nº 200447167 **rejeitando** o pedido de **dilação probatória** ao fundamento de que "*o objeto da lide versa sobre o dever ou não de cobertura de hormônio de crescimento requisitado pelo endocrinologista pediatra que assiste à jovem ANA BEATRIZ, de modo que a perícia médica afeiçoa-se de todo despicienda no caso concreto, ficando de logo rejeitada (art. 370, par. único, CPC)*".

Houve **alegações finais reiterativas** (ID nº 201965519 e nº 202967375).

Do que importa, é o relato. Pronuncio-me.

Inexistindo questões prévias pendentes de apreciação, e estando por isso o feito em ordem, **adentro de imediato ao mérito da causa**.

De início, destaco que o contrato objeto da presente demanda — plano de assistência médica suplementar — configura típica **relação de consumo**, estando submetido à disciplina do **Código de Defesa do Consumidor**, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A parte autora, na qualidade de beneficiária de plano de saúde contratado para atendimento pessoal e familiar, enquadra-se como **consumidora final dos serviços prestados**, enquanto a ré, operadora de plano de saúde, é fornecedora de serviços remunerados no mercado de consumo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa premissa. Consoante a **Súmula 608/STJ**, "**Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão**".

O enunciado acima orienta, de forma vinculante, que a atividade desempenhada por operadoras privadas — como é o caso da demandada — sujeita-se aos **princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, transparência e função social do contrato.**

O reconhecimento da natureza consumerista da relação impõe, ainda, a possibilidade de **interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor**, bem como a aferição da **abusividade de eventuais cláusulas restritivas**, especialmente quando implicam limitação ao direito fundamental à saúde, constitucionalmente assegurado no art. 6º, caput, e art. 196 da Constituição Federal.

Estabelecido, pois, o regime jurídico aplicável, passa-se à análise dos demais pontos controvertidos.

Seguindo neste rumo de pensar, denoto que a tese de defesa formulada pela operadora ré repousa na suposta existência de **doença ou lesão preexistente (DLP)** à data de contratação do plano de saúde, com o argumento de que haveria omissão dolosa no preenchimento da declaração de saúde e que, por conseguinte, o tratamento requerido estaria excluído da cobertura por força da **cobertura parcial temporária (CPT)**, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa nº 162/2007 da ANS.

Entretanto, tal alegação **não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos**.

A começar pelo conceito técnico-jurídico de **DLP**, nos termos da ANS, exige-se não apenas a existência de condição clínica anterior, mas também que esta seja **conhecida e sabidamente existente pelo beneficiário** no momento da adesão ao plano. A própria **RN nº 162/2007** estabelece como requisito essencial a **ciência inequívoca do contratante sobre a enfermidade ou lesão**, sendo **inadmissível presumir o conhecimento técnico sobre uma condição ainda em fase de investigação clínica**.

Se não, leia-se:

> *Art. 2º - Para fins desta Resolução, considera-se:*
>
> *I - **Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal <u>saiba</u> ser portador ou sofredor, no momento da contratação** ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei nº 9656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art 4º da Lei nº 9961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução;*

No caso dos autos, os documentos médicos apresentados indicam que a menor **passou a ser submetida à avaliação diagnóstica após a contratação do plano**, não havendo qualquer elemento que demonstre que, **à época da adesão**, havia **diagnóstico fechado, informado ou de conhecimento da genitora da autora**. Não há nos autos exames conclusivos ou laudos anteriores à contratação que comprovem a ciência da patologia ou a instauração formal do tratamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca ao dispor que **a operadora somente pode se eximir da cobertura mediante prova robusta de má-fé**, conforme estabelece o **art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor**, que impõe ao fornecedor o ônus da prova quando verificada a vulnerabilidade técnica do consumidor.

Com efeito, a **Súmula 609 do STJ** dispõe que:

> *"**A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado**".*

Tal entendimento é extensível aos planos de saúde. Ora, se a operadora, no ato da adesão, **não se valeu do direito de submeter a beneficiária à perícia médica**, tampouco exigiu exames clínicos prévios, **assumiu o risco do desconhecimento técnico**, não podendo invocar, *ex post*, a preexistência da enfermidade como fundamento para negar cobertura, **sem a mínima comprovação de que a beneficiária tinha plena ciência do diagnóstico à época da contratação**.

Por fim, a simples menção de datas em laudos posteriores ou a cronologia do processo diagnóstico **não supre o ônus probatório da ré**. Em se tratando de menor em desenvolvimento, a hipótese de condição latente ou em curso de investigação não se confunde com omissão dolosa ou fraude contratual.

Ausente a demonstração cabal de má-fé, a negativa de cobertura **revela-se indevida e abusiva**, devendo ser repelida.

Ainda neste viés, há de se destacar que, em conformidade com o regramento estampado na legislação consumerista, o direito lastreado na boa fé ostenta especial relevância em prol do consumidor, mormente quando se cuida de situação de risco no que concerne à higidez física dos pacientes (arts. 5º e 196 da Constituição Federal) situação essa que se acha patenteada no teor do documento médico que sinaliza para a necessidade de submeter a suplicante, de tenra idade avançada e vítima de **baixa estatura associada à deficiência do hormônio de crescimento**, à referida intervenção medicamentosa com **Somatropina (Genotropin)**.

Com efeito, cabível assentar que a **perpetuação da doença** sem o devido tratamento ensejaria **dano físico e social irreparável**, o qual exige premente e pronta alberga judicial.

Para além disso, cumpre assentar que o CDC é norma de ordem pública (art. 5º, XXXII, da CF), sendo certo que o plano de assistência médico-hospitalar é contrato de trato sucessivo, que se renova a cada mensalidade.

A Constituição Federal assim prescreve:

> ***Art. 196**. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

É que entende este Juízo, em consonância com a moderna jurisprudência, que **a circunspeção e seriedade da moléstia, passível de cobertura contratual como no caso, bem como o prazo para o respectivo tratamento, não podem ser aferidos pela análise administrativa da empresa seguradora**. Antes, é ilação a que apenas o médico assistente pode chegar, mediante a anamnese da situação em concreto.

Ademais, é pacífico o entendimento de que compete ao médico assistente determinar qual o tratamento que deverá ser aplicado ao paciente.

Neste viés, o Superior Tribunal de Justiça já apascentou que "***o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura***" (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).

Consoante a Lei Consumerista, as **cláusulas restritivas de direitos devem estar redigidas de maneira destacada**, possibilitando assim a fácil percepção da parte contratante que, por se tratar de simples aderente e ostentar posição econômica induvidosamente inferior, qualifica-se como **hipossuficiente**.

Nesta esteira, inolvide-se a previsão legal contida no §4º do artigo 54 do referido diploma legal que, ao tratar dos contratos de adesão, dispõe que "***as cláusulas que implicarem limitações de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão**".*

Conforme deflui da singela leitura da defesa, a ressalva material da operadora ré repousa no fato de que não estaria obrigada a custear o fármaco, por não constar de cláusula contratual e do Rol da ANS, dado ser de uso domiciliar.

Todavia, ainda que haja cláusula contratual ou dispositivo regulamentar administrativo nesse sentido, tal realidade não seria suficiente para a empresa demandada eximir-se de custear a **medicação**, haja vista que tal procedimento configurou-se como **indispensável à higidez física da paciente**.

Em razão do quadro clínico da demandante, considerar legal e admissível a intenção da parte ré de escusar-se do custeio do **tratamento farmacológico** específicoa requerido pelo médico assistente seria negar amparo e garantia ao bem jurídico maior tutelado pelo nosso ordenamento jurídico, qual seja, a **vida saudável**.

O princípio constitucional do direito à vida e à saúde e do dever das seguradoras, em substituição ao Estado, oferecer sua escorreita prestação não devem ser considerados em planos inferiores aos dos casuísmos normativos ou contratuais, nem à burocracia das firmas contraentes, revelando-se direito líquido e certo da parte acionante, amparável na via ordinária, a cobertura do tratamento.

Assim, a operadora é obrigada a garantir o medicamento **Somatropina (Genotropin)**.

Ainda neste segmento, julgo ser **ilegal a recusa à concessão da cobertura**, vez que ainda que a ANS, no seu Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não tenha incluído a **Somatropina (Genotropin)** para déficit de crescimento ou mesmo deste não constar nas diretrizes de utilização para o procedimento necessário ao paciente, cuido tratar-se de **listagem meramente exemplificativa e de cobertura mínima**, não devendo ser considerada taxativa a excluir a responsabilidade de fornecimento do tratamento, sendo a negativa incompatível com os princípios da equidade e boa-fé.

O tema se encontrava divergente entre a Quarta e a Terceira Turmas do Superior Tribunal de Justiça. Desde então, sempre perfilhei o entendimento da Terceira Turma, a qual, no contexto, transcrevo:

> *AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL (CPC/2015). DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PALBOCICLIBE (IBRANCE). RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUATRAMENTO NA DIRETRIZ DE COBERTURA DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES DA ANS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA TURMA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.*
>
> *1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura do medicamento antineoplásico PALBOCICLIBE (IBRANCE) a paciente acometida de câncer de mama metastático, tendo havido recusa da operadora sob o fundamento de ausência de enquadramento do caso nas diretrizes de utilização previstas no rol de procedimentos mínimos da ANS.*
>
> ***2. Caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, na linha da jurisprudência pacífica desta TURMA, firmada com base na função social do contrato de plano de saúde.***
>
> *3. Caso concreto em que a paciente se encontra acometida de doença oncológica grave e progressiva, de modo que a recusa genérica de cobertura (sem instauração de junta médica nos termos da RN ANS 424/2017) deixou a paciente padecendo à própria sorte no tratamento da doença, desatendendo assim à função social do contrato, segundo a linha de entendimento desta TURMA.*
>
> *4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*
>
> *(AgInt no REsp 1911407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)*
>
> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO. ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL.*
>
> *REEXAME DE PROVAS.*
>
> *1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).*
>
> *2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.*
>
> ***3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.***

4. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1899424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Ainda neste viés, a Corte de Uniformização Infraconstitucional também se define "*no sentido de que são abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, cabendo apenas ao profissional habilitado - e não ao plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente".* (AgInt no REsp 1870789/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Ademais, também recentemente, caiu por terra a discussão existente sobre a taxatividade do Rol da ANS e a obrigatoriedade de custeio de tratamentos não previstos na lista ofertada pela Agência Reguladora.

A já mencionada Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656, de 1998 (http://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:1998-06-03;9656), estabelece que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (RPES), atualizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), servirá apenas como referência básica para os planos privados de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Desta feita, acha-se definitivamente profligado o entendimento pelo "rol taxativo" para a cobertura de planos de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos ainda que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Tratamentos fora dessa lista deverão ser aceitos, desde que cumpram uma das condicionantes: ter eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ter recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou ter recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.

Vejamos:

Art. 10. (…)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; *ou*

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

É bem esse o caso dos autos.

Em efeito, importa destacar que o fármaco em questão possui **registro ativo junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa**, sob o número **1.1013.0045**, estando classificado como **medicamento biológico sujeito à prescrição médica e com comercialização regular autorizada no território nacional**.

Conforme consta no banco de dados oficial da Anvisa, o medicamento é aprovado para múltiplas indicações clínicas, dentre as quais se inclui expressamente a **deficiência de hormônio do crescimento em crianças e adolescentes**, quadro que fundamenta a prescrição nos autos. Sua via de administração é subcutânea, e sua aplicação é rotineiramente realizada em ambiente ambulatorial ou domiciliar, sob acompanhamento especializado.

A existência de **registro sanitário vigente atesta a segurança, eficácia e qualidade do medicamento**, nos termos da legislação federal de vigilância sanitária, afastando qualquer dúvida quanto à sua licitude ou adequação terapêutica. Nessa perspectiva, mostra-se indevida a negativa de cobertura baseada em suposta ausência de previsão contratual ou por tratar-se de medicamento de uso extrahospitalar, uma vez que **se trata de medicamento essencial prescrito com fundamento técnico e regulação sanitária compatível**.

Por isso, entendo que a mencionada negativa, ainda que lastreada em anteparo contratual, não merece guarida no ordenamento jurídico pátrio.

Nos contratos onde existem cláusulas que venham prejudicar a parte mais fraca da relação de consumo, em detrimento das máximas da boa-fé objetiva e da confiança, há que se as considerar abusivas, devendo ser reconhecidas judicialmente por meio de ação ou reconvenção, de exceção ou por ato *ex officio* do Juiz.

O artigo 51, incisos IV e IX do CDC, dispõe:

> *Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)*
>
> *IV estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a eqüidade; (...)*
>
> *IX deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor.*

Inobstante tal realidade, a empresa demandada persistiu em negar a cobertura do tratamento integral, sugerindo reembolsá-lo apenas parcialmente, nada obstante não ostente estabelecimento e profissionais vinculados capacitados para tanto, olvidando assim as garantias constitucionais e da legislação consumerista.

Sopesando, em conclusão todos os argumentos expendidos, tenho que se afeiçoa induvidoso que o pleito formulado pela autora merece acolhimento.

Por outro lado, a exclusão do dever de cobertura por cláusula contratual ou instrumentos de convênio firmados com terceiros, malgrado descrita em supostos estudos atuariais, constitui indisfarçável e frontal violação do regramento estampado na legislação protetiva do hipossuficiente porquanto soa implausível, eivada a não mais poder de abusividade e, *pour cète cause*, nula de pleno direito, o que fica aqui expressamente reconhecido e declarado, na forma do art. 52 inc. IV da Lei 8.078/1990, e art. 168 par. único do CC (antigo, art. 146 par. único).

Não se pode olvidar que, imbuída da mais intangível boa-fé, acedeu a parte autora às letras previamente anotadas pela seguradora na esperança de ver resguardados seus direitos e liberdades constitucionais, no que dizem com sua dignidade, vida e incolumidade física e mental. Decerto, perseguir valores indevidos ou negar cobertura securitária quando se evidencia negligência ou mesmo cavilosidade na arguição do dispositivo da avença concernente à imprevisão no ajuste é clausular a iniquidade e a abusividade, o que, face à ordem normativa consumerista, não pode prosperar.

Por isso, entendo que a mencionada negativa, ainda que lastreada em anteparo contratual ou no parecer de médicos de comitê subordinado à operadora, não merece guarida no ordenamento jurídico pátrio.

O princípio constitucional do direito à vida e à saúde e do dever das seguradoras, em substituição ao Estado, oferecer sua escorreita prestação não devem ser considerados em planos inferiores aos dos casuísmos normativos ou contratuais, nem à burocracia das firmas contraentes, revelando-se direito líquido e certo da parte acionante, amparável na via ordinária, a reparação pelas expensas com a realização do seu tratamento nos exatos moldes indicados pelo médico assistente.

É de se ressaltar que o dever de assistência à saúde dos cidadãos surge como uma das formas de garantia do direito à vida localizado no caput do art. 5º da CF, caracterizando-se, pois, como cláusula pétrea, de modo a impedir que o legislador, assim como o administrador, criem situações que impliquem esvaziamento do conteúdo desse dispositivo constitucional.

Para além da estreita relação com o direito à vida, o direito à assistência à saúde possui intrínseca relação com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, razão pela qual, conclui-se, qualquer previsão legal, bem como quaisquer atitudes tomadas pelo Poder Público que provoquem o esvaziamento do direito à vida trará, como corolário, o desrespeito à dignidade da pessoa humana, pois são dois vetores considerados igualmente fundamentais pela Constituição.

Em nosso País, o direito à existência digna é refletido, entre outros aspectos, pela obrigação atribuída a quem quer que seja (Estado, operadoras de planos de saúde suplementar etc.) de realizar ações integradas destinadas a assegurar a prestação dos direitos inerentes à saúde, à previdência e à assistência social, incluídas, nesse contexto, ações que garantam acesso universal igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Assim é que qualquer omissão no papel de garantidor desse direito abrirá ensejo para a propositura de medidas judiciais, não somente naquelas situações em que ele não garantir o direito à saúde, mas também quando o assegurar de forma ineficiente.

No caso vertente, verificando os fatos e argumentos expendidos na exordial e os documentos acostados, não sobeja dúvida que o pacto firmado entre os litigantes reveste-se da roupagem estritamente adesiva. Por outro lado, é cristalino que o caso *sub judice* versa sobre uma relação de consumo, devendo, portanto, ser observado o Código de Defesa do Consumidor.

Destaco ainda que, **nada obstante a letra fria do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98**, **o fato de o medicamento ser de uso domiciliar, não afasta o dever de cobertura, no caso concreto.**

Apoiando este pensar, confira-se:

> *PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. PRECEDENTES. DANO MORAL CABIMENTO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.*
>
> *(...)*
>
> ***2. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes.***
>
> *3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que configura óbice da Súmula nº 7 do STJ.*
>
> *(...)*
>
> *(AgInt no AREsp 1285474/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)*

> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO.*
>
> ***1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.***
>
> *2. Agravo interno a que se nega provimento.*
>
> *(AgInt no AREsp 1064435/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)*

Da Corte Pernambucana, colaciono:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. USO EM AMBIENTE DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO INERENTE AO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO À SAÚDE DA PACIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DA SEGURADORA.*
>
> *1. A controvérsia a ser dirimida nestes autos está restrita ao cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do CPC/2015, portanto, está atrelada à questão estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão de tutela dessa natureza, sendo que as demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e devem ser analisadas em momento oportuno.*
>
> ***2. In casu, agravante foi diagnosticado com Baixa Estatura Idiopática (CID E34.3), sendo necessário, segundo laudo médico, o uso de bloqueador de puberdade e estimulação hormonal de crescimento.***
>
> ***3. É ilegal/abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento requerido, uma vez que compete ao especialista responsável por acompanhar o paciente, e não ao plano de saúde, eleger qual o tratamento necessário e adequado à sua cura/melhora/sobrevivência. Negar tal cobertura fere o princípio da boa-fé, indo de encontro à própria finalidade do contrato, haja vista que restringe direitos/obrigações fundamentais do contrato de seguro saúde e impõe desvantagem excessiva ao beneficiário. Ofensa aos arts. 6º, IV; 39, V; e 51, IV e §1º, II, do CDC.***
>
> ***4. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde - Lei***

14.454/2021, não tendo sido indicado pela OPS substituto terapêutico.

5. Agravo de Instrumento a que se dá provimento. Prejudicado o Agravo Interno.

(TJPE, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0023496-73.2023.8.17.9000, Rel. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC), julgado em 30/04/2024, DJe)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES DA 1ª CÂMARA CÍVEL DO TJPE.

1. A recente Resolução Normativa 465 de fevereiro de 2021, da Agência Nacional de Saúde - ANS, revogou a RN 428/2017, incluindo o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol e Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I (Pág. 62), o qual elenca os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória. Dessa forma, a seguradora está obrigada ao fornecimento do hormônio do crescimento por expressa previsão da RN. 465/2021, pois o tratamento é de cobertura obrigatória e deve constar no contrato. Precedentes da 1ª Câmara Cível do TJPE.

2. Apelação a que se dá parcial provimento.

(TJPE, APELAÇÃO CÍVEL 0105316-33.2021.8.17.2001, Rel. FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC), julgado em 30/04/2024, DJe)

Por fim, não se pode negar que, em princípio, devem ser atendidas as Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ocorre que, ante o caráter exemplificativo dessa lista de procedimentos, também **suas diretrizes devem ser encaradas *cum granum salis***, posto que, como é cediço, a norma jurídica anda a pé, enquanto o fato social corre a cavalo.

Amparando essa ilação, confira-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME ONCOLÓGICO. PET SCAN. CONSUMIDORA DIAGNOSTICADA COM TUMOR NEUROENDÓCRINO. ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de consumidora diagnosticada com tumor neuroendócrino com indícios de metástase, a indicação de exame PET-SCAN deve ser autorizada pela operadora de plano de saúde, por adequação às Diretrizes de Utilização – DUT do Rol de Procedimentos da ANS.

2. Ainda assim, independentemente de adequação às DUT, o caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos da ANS torna obrigatória a cobertura do exame requisitado, uma vez que se trata de procedimento previsto como obrigatório.

3. Recurso desprovido.

(TJPE, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0001590-47.2020.8.17.9480, Rel. RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior, julgado em 23/02/2022, DJe)

Por fim, quanto ao **pedido indenizatório**, exsurge nitidamente que ele merece prosperar nos termos os artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil.

O **dano e a relação de causalidade estão presentes** não só pela recusa velada e pela expressa negativa de vigência do contrato, mas pelo sentido de perda em relação à reparação da saúde em momento delicadíssimo da parte autora, objetivo primordial dos procedimentos médicos irregularmente dificultados e vetados.

Respeitante ao pedido alusivo aos danos morais, permite-se este Juízo deixar assentada breve conceituação pela qual "*danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico*" (SILVA, Wilson de Melo da. **O Dano Moral e sua Reparação**, Rio, 1995, n° 01).

Por certo, infligir ao paciente – uma criança debilitada pela moléstia que lhe acomete - o ônus de vir a Juízo buscar a efetivação das suas prerrogativas, em detrimento da paulatina dor e sofrimento que se acha experimentando, significa vulnerar-lhe com absurda iniquidade a aprazia e o bem-estar, carecendo da pronta compensação financeira.

Por suposto, "*embora geralmente o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada*" (STJ - AgRg no REsp 1.328.978/RS - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - Julg. 13.11.2012 - DJe 20.11.2012)

O lesionamento, na espécie, não depende de prova de outros prejuízos ao patrimônio material, espiritual ou físico do postulante, porquanto se caracteriza *in re ipsa*.

A jurisprudência da Corte Estadual, ademais, foi pacificada no sentido de que a negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde rende ensejo à indenização por dano moral (**Súmula 35 do TJPE**).

Em conclusão, tenho ser indevida a recusa da parte ré em autorizar o exato e integral tratamento de saúde parte da autora e em cobrir todas as despesas com o tratamento médico do paciente nos termos solicitado pelo médico assistente, devendo suportar os custos com a cobertura devida em relação ao contrato celebrado entre as partes, por abusiva restrição, além da **indenização por dano moral**, este arbitrado em **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)** considerando a intensa extensão do dano suportado pelo demandante e as condições pessoais das partes, com atenção ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, cumpre assentar, por conveniente, que a fixação dos danos morais em montante inferior àquele pretendido pela parte na peça de ingresso não importa sucumbência recíproca, nos exatos termos da **Súmula 326, STJ**.

Isto posto e por tudo que restou provado nos autos, tenho por imperativo julgar **PROCEDENTES** os pedidos que se acham contemplados na presente ação ordinária para:

a) **confirmando** a liminar preteritamente concedida, **condenar** a demandada na obrigação de fazer consistente na cobertura integral do tratamento farmacológico do paciente portador de baixa estatura, nos exatos moldes requisitados pelo médico assistente, sob pena das astreintes já arbitradas.

b) **imputar** ainda a obrigação de indenizar a parte postulante, em aspecto compensatório pelos sofrimentos e danos extrapatrimoniais que valoro no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a repercussão e reprovabilidade do fato, bem assim a condição socioeconômica das partes litigantes (art. 944, CC), quantia a ser monetariamente corrigida pela Taxa SELIC (que já engloba correção e juros de mora) desde este *decisum* (Súmula 362, STJ).

Ressalto que, no caso concreto, não tendo ocorrido sequer notícia de solução de continuidade ao tratamento, fica afastada a imputação concreta da multa periódica.

Na oportunidade, extingo o presente feito por sentença com apreciação nuclear, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, imputando aos demandados o **ônus sucumbencial** representado pelas custas processuais e taxa judiciária em aberto, além de honorários advocatícios na ordem de 15% do valor da condenação, incluindo indenização e obrigação de fazer, tudo lastreado nos **arts. 82, §2º, e 85, §2º, ambos do CPC/2015, e Súmula 199, TJPE**.

Independentemente de nova intimação, deverá a parte demandada **comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais** no prazo de quinze (15) dias úteis contados do trânsito em julgado, sob pena de que se oficie imediatamente ao Comitê Gestor de Arrecadação do TJPE (ou quem lhe faça a vezes) para adoção das providências de cobrança cabíveis, incluindo a multa de 20%, na forma dos arts. 22 e 27, §3º, da nova lei de custas (Lei Estadual nº 17.116/2020).

Intimem-se. Cumpra-se.

Recife-PE, data da assinatura digital.

Robinson José de Albuquerque Lima

Juiz de Direito

bfsma

Assinado eletronicamente por: ROBINSON JOSE DE ALBUQUERQUE LIMA
09/05/2025 15:32:26
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 203438452

25050915322649700000198173026

IMPRIMIR GERAR PDF